

Otitis externa aguda y crónica

1. Introducción y relevancia clínica

La **otitis externa (OE)** es una **inflamación infecciosa o irritativa del conducto auditivo externo (CAE)**, que puede extenderse al pabellón auricular y tejidos periauriculares. Se clasifica principalmente en **aguda** y **crónica** según la duración y características clínicas.

Es una **patología muy común en atención primaria**, sobre todo en meses cálidos y húmedos o en nadadores (“oído del nadador”). En Chile, su prevalencia aumenta durante el verano, siendo una de las principales causas de consulta ORL.

El diagnóstico es **clínico**, y el tratamiento precoz evita complicaciones graves como **celulitis periauricular** o **la otitis externa maligna**, esta última potencialmente mortal en pacientes diabéticos o inmunodeprimidos.

2. Fisiopatología y bases conceptuales

El conducto auditivo externo (CAE) tiene una función protectora y autolimpiante, gracias al **cerumen**, que mantiene un **pH ácido (4–5)** y una **barrera antimicrobiana natural**.

Cuando esta defensa se altera por humedad, trauma o manipulación, se favorece la colonización bacteriana o fúngica.

2.1 Otitis externa aguda (OEA)

Fisiopatología:

- Daño en la barrera epitelial → aumento del pH → proliferación bacteriana.
- La humedad macera la piel, y los traumatismos (cotonitos, audífonos) permiten la entrada de gérmenes.

Gérmenes más frecuentes:

Agente

Frecuencia

Características

<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	50–70%	Olor fétido, secreción verdosa
<i>Staphylococcus aureus</i>	20–30%	Secreción purulenta, costras
<i>Candida spp.</i> , <i>Aspergillus spp.</i>	<10%	Forma micótica (crónica o postantibiótica)

Factores predisponentes:

- Humedad (piscinas, sudor, baños frecuentes).
- Limpieza excesiva o uso de cotonitos.
- Tapones, audífonos o prótesis auditivas.
- Diabetes mellitus, dermatitis seborreica o eccema.
- Falta o exceso de cerumen.

2.2 Otitis externa crónica (OEC)

Definición: Inflamación persistente del CAE **>6 semanas**, asociada a infección fúngica, dermatitis o irritación crónica.

Fisiopatología:

- Cambios distróficos de la piel del conducto → engrosamiento, descamación y estenosis parcial.
- Colonización por bacterias o hongos oportunistas.

Gérmenes comunes: *Pseudomonas aeruginosa*, *Staphylococcus aureus*, *Aspergillus niger*, *Candida albicans*.

3. Clínica (signos, síntomas y diagnóstico diferencial)

3.1 Otitis externa aguda

Síntomas cardinales:

- **Dolor intenso (otalgia):** aumenta al traccionar el pabellón o presionar el trago.
- **Prurito inicial**, luego dolor constante.
- **Sensación de oído tapado o hipoacusia conductiva.**
- **Otorrea purulenta o serosa.**

Signos en otoscopía:

- Conducto auditivo externo **eritematoso, edematoso**, con **secreción o costras**.
- Dolor importante al introducir el espéculo.
- Membrana timpánica habitualmente **íntegra** pero difícil de visualizar.

Evolución típica:

Inicio agudo (horas-días), duración de 7–10 días con tratamiento adecuado.

3.2 Otitis externa crónica

Síntomas:

- **Prurito persistente** (síntoma más común).
- **Molestia leve** o sensación de plenitud.
- **Secreción escasa o serosa**, sin dolor significativo.
- **Engrosamiento cutáneo**, descamación o estenosis del CAE.

Otoscopía:

- Piel seca, engrosada o con exudado mucoso.
 - Posible visualización de **micelios fúngicos** (puntos negros o filamentos blanquecinos).
-

3.3 Diagnóstico diferencial

Diagnóstico	Características diferenciales
Otitis media aguda con otorrea	Membrana timpánica perforada, sin dolor al movilizar pabellón
Eczema o dermatitis del CAE	Prurito sin secreción purulenta
Furúnculo del CAE (forunculosis)	Dolor localizado, absceso visible en tercio externo
Otitis externa maligna	Dolor intenso + tejido de granulación + diabetes

4. Exámenes complementarios y criterios diagnósticos

El **diagnóstico es clínico** en la mayoría de los casos.

Sin embargo, se consideran exámenes complementarios en casos atípicos o refractarios.

Situación	Examen	Utilidad
Otorrea persistente >2 semanas	Cultivo de secreción	Identificar germen y sensibilidad
Sospecha de infección fúngica	Examen directo con KOH	Detección de hifas o esporas
Dolor intenso o extensión periauricular	TAC de peñasco o mastoides	Descartar otitis externa maligna

Pacientes inmunodeprimidos

Hemograma, glicemia

Evaluación sistémica

Criterios diagnósticos clínicos de otitis externa aguda (según MINSAL):

1. Dolor a la palpación del trago o tracción del pabellón.
 2. Eritema o edema del CAE.
 3. Presencia de secreción o exudado.
 4. Tímpano indemne.
-

5. Tratamiento (según guías MINSAL / Chile)

El manejo depende de la forma clínica (aguda o crónica) y la extensión.

5.1 Medidas generales

- Evitar **manipulación del oído** y mantenerlo **seco**.
 - Suspendir uso de audífonos o tapones.
 - En caso de nadadores: proteger el oído con tapones de silicona y secado cuidadoso.
-

5.2 Tratamiento tópico (primera línea)

1□ Antibióticos tópicos

- Eficaces contra *Pseudomonas* y *S. aureus*.
- Se prefieren preparados **combinados con corticoides** (por ejemplo, ciprofloxacino + dexametasona).

Opciones disponibles:

Medicamento	Dosis	Duración	Observaciones
Ciprofloxacino + dexametasona	3 gotas cada 8 h	7–10 días	Elección en Chile (MINSAL)
Polimixina B + neomicina + hidrocortisona	3 gotas cada 8 h	7 días	Evitar si perforación timpánica
Ácido acético 2%	3 gotas cada 6–8 h	5–7 días	Alternativa económica, mantiene pH ácido

Importante:

- Si el conducto está muy edematoso → colocar **mecha de gasa** con antibiótico cada 24 h.
- **No usar antibióticos orales** salvo extensión o compromiso periauricular.

5.3 Tratamiento sistémico (según MINSAL)

Indicado solo si:

- Infección se extiende a tejidos blandos periuriculares.
- Linfadenitis regional.
- Paciente inmunodeprimido o diabético.

Antibiótico sugerido:

- Ciprofloxacino VO 500 mg cada 12 h por 7–10 días.

5.4 Otitis externa fúngica

- Limpiar cuidadosamente el conducto (aspiración o lavado ácido).
- Antimicóticos tópicos:
 - Clotrimazol gotas 1% cada 12 h por 7–10 días.
 - Ácido bórico 3% o alcohol bórico.
- Evitar antibióticos prolongados que predisponen a recidiva fúngica.

5.5 Otitis externa crónica

- Identificar y eliminar factores irritativos (audífonos, dermatitis).
 - Limpieza periódica y gotas acidificantes (acético o bórico).
 - En casos severos o recidivantes → derivar a ORL para microaspiración y cultivo.
-

6. Complicaciones y pronóstico

Complicación	Mecanismo	Prevención / Manejo
Otitis externa maligna	Diseminación ósea por <i>Pseudomonas</i> en diabéticos	Tratamiento precoz, controlar glicemia
Celulitis periauricular	Propagación local	Antibióticos sistémicos
Estenosis del CAE	Inflamación crónica	Limpieza y antiinflamatorios tópicos
Hipoacusia conductiva reversible	Obstrucción del conducto	Limpieza post-tratamiento

Recaídas

Humedad o manipulación

Educación del paciente

Pronóstico:

Excelente en otitis externa aguda tratada precozmente.

En casos crónicos o micóticos, puede requerir manejo prolongado, pero rara vez deja secuelas.

7. Perlas clínicas y errores comunes en EUNACOM

Perlas clínicas

1. **Dolor al traccionar el pabellón o presionar el trago** = signo patognomónico de otitis externa.
2. Evitar siempre el uso de **cotonitos**, principal causa predisponente.
3. Si hay **diabetes o inmunosupresión**, descartar **otitis externa maligna**.
4. El **tímpano íntegro** diferencia otitis externa de media.
5. Gotas con **ciprofloxacino + corticoide** son tratamiento de elección.
6. En niños, puede simular otitis media: siempre inspeccionar CAE antes de indicar antibióticos sistémicos.
7. En casos micóticos, el **clotrimazol tópico** es suficiente tras limpieza.

Errores comunes

- Usar antibióticos sistémicos innecesariamente.
- Irrigar oído con tímpano perforado.
- No secar el conducto tras natación o duchas.
- No cambiar gotas si no hay respuesta en 48–72 h.

- Ignorar dolor severo y persistente en diabéticos (posible OE maligna).
-

8. Resumen final (5–7 ideas clave)

1. La **otitis externa** es una infección inflamatoria del CAE causada principalmente por *Pseudomonas* y *S. aureus*.
2. Se clasifica en **aguda (<6 sem)** y **crónica (>6 sem)**.
3. El diagnóstico es **clínico**: dolor al traccionar pabellón, edema y secreción con tímpano íntegro.
4. El tratamiento se basa en **antibióticos tópicos combinados con corticoides** y medidas higiénicas.
5. Evitar manipulación e irrigación en casos con sospecha de perforación.
6. En diabéticos o inmunodeprimidos, descartar siempre **otitis externa maligna**.
7. La **educación preventiva** (no usar cotonitos, mantener el oído seco) es clave para evitar recurrencias.